

TEMA 3.50 • OBSTETRICIA

Puerperio Patológico — Endometritis y Trombosis

PERFIL EUNACOM 1.03.50

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Puerperio Patológico — Endometritis y Trombosis

Fiebre Puerperal

Manejo: buscar y tratar la causa. Examen físico completo + exámenes según sospecha.

TABLA 3.50.1: CAUSA FRECUENTE VS EXAMEN A SOLICITAR	
CAUSA FRECUENTE	EXAMEN A SOLICITAR
Endometritis	Clínico (+ hemograma si necesario)
TEP	Angiotac de tórax
Mastitis	Clínico
Tromboflebitis séptica	TAC / RMN pelvis

Endometritis Puerperal

Causa: infección polimicrobiana ascendente desde el tracto vaginal hacia la cavidad uterina (abierta por el parto).

Clínica

Tríada: dolor + fiebre + leucorrea (misma tríada que PIB y corioamnionitis, pero en puérpera)

- ± **Metrorragia tardía** (desde el 3er día en adelante — puede enmascarar la leucorrea)

Diagnóstico

Clínico: 2 de 3 criterios (dolor, fiebre, leucorrea).

Tratamiento

ATB de amplio espectro EV → hospitalizar

TABLA 3.50.2: ESQUEMA VS PRIMERA LÍNEA		
ESQUEMA	PRIMERA LÍNEA	COBERTURA
Clindamicina + gentamicina	1ª línea	Clinda: anaerobios + gram(+); Gentamicina: gram(-)
+ Ampicilina	Si no responde en ~48 h	Mejor cobertura para estreptococos

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Sin respuesta al tratamiento → sospechar tromboflebitis séptica (complicación frecuente).

Casos graves (choque séptico, miometritis grave) → **histerectomía** como última línea.

Tromboflebitis Séptica Pelviana

Definición: complicación de endometritis con trombosis de venas pélvicas.

Sospecha cuando: endometritis que **no mejora con antibióticos**.

- Raramente puede generar TEP

Diagnóstico: TAC o RMN de pelvis (endometritis + trombosis venosa).

Tratamiento: ATB (mismo esquema endometritis) + **anticoagulación** (heparina → anticoagulante oral).

TVP / TEP en el Puerperio

- El embarazo y el puerperio son **factores de riesgo** para trombosis
- Clínica, diagnóstico y tratamiento **iguales a mujeres no puérperas**
- Diagnóstico: **angiotac** (con variaciones según contexto)
- Tratamiento: **soporte + anticoagulación**

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Regla práctica: si parece una TVP o TEP en contexto puerperal → es una TVP o TEP **hasta que se demuestre lo contrario**.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Respecto a Puerperio Patológico — Endometritis y Trombosis, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA para el EUNACOM?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Puerperio Patológico — Endometritis y Trombosis. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Fiebre Puerperal
- Endometritis Puerperal
- Clínica
- Diagnóstico
- Tratamiento
- Tromboflebitis Séptica Pelviana
- TVP / TEP en el Puerperio

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (PUERPERIO PATOLÓGICO — ENDOMETRITIS Y TROMBOSIS)**PREGUNTA 1**

Respecto a Puerperio Patológico — Endometritis y Trombosis, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA para el EUNACOM?

- A)** El diagnóstico de Puerperio Patológico — Endometritis y Trombosis se basa exclusivamente en criterios de laboratorio
- B)** El manejo inicial de Puerperio Patológico — Endometritis y Trombosis debe orientarse según el estado clínico del paciente
- C)** Todo paciente con Puerperio Patológico — Endometritis y Trombosis requiere hospitalización inmediata
- D)** El tratamiento de Puerperio Patológico — Endometritis y Trombosis es igual en todas las edades y contextos clínicos
- E)** El seguimiento de Puerperio Patológico — Endometritis y Trombosis no es necesario una vez iniciado el tratamiento

PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en Puerperio Patológico — Endometritis y Trombosis?

- A)** Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- B)** Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- C)** Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- D)** Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- E)** Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con Puerperio Patológico — Endometritis y Trombosis. Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- A)** Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- B)** Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- C)** Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- D)** Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- E)** Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

RESUMEN: PUERPERIO PATOLÓGICO — ENDOMETRITIS Y TROMBOSIS

Causa: infección polimicrobiana ascendente desde el tracto vaginal hacia la cavidad uterina (abierto por el parto). :::tip Regla práctica: si parece una TVP o TEP en contexto puerperal → es una TVP o TEP hasta que se demuestre lo contrario. :::